



SINIESTRALIDAD SECTORIAL: CAUSAS Y PLAN DE MEJORA EN ENTORNOS DE SISTEMAS



TIPOLOGÍAS DE SINIESTRALIDAD

1. La siniestralidad laboral incluye Accidentes de Trabajo (AT), Enfermedades Profesionales (EP) y otras patologías no específicas (como el estrés). 2. En el sector de servicios (Informática), los daños más representativos son los Trastornos Musculoesqueléticos (TME). 3. Los TME son lesiones de músculos, tendones y articulaciones, frecuentes en el cuello, extremidades superiores y la zona dorsolumbar en puestos de oficina.



CAUSAS COMUNES EN SISTEMAS

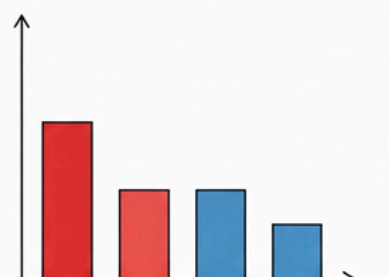
1. Causa Ergonómica: Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos (tecleo, ratón) y la fatiga visual al trabajar con Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 2. Causa Psicosocial: El Estrés y el Burnout generados por la alta carga mental, la presión de plazos y el ritmo de trabajo frenético. 3. Causa de Seguridad: Caídas al mismo nivel por tropiezos con objetos (cables, herramientas) o por la falta de orden y limpieza en el entorno de trabajo.

PROPUESTAS DE MEJORA Y LEGISLACIÓN

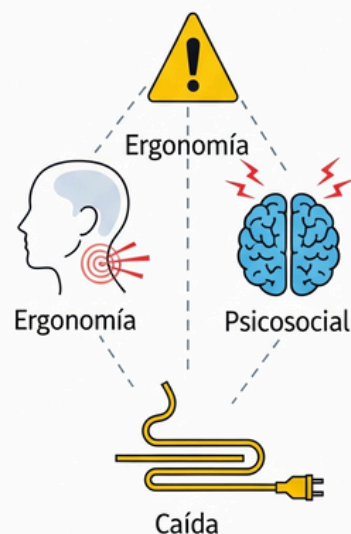
1. Mejora: Aplicar el principio de Adaptar el Puesto a la Persona, asegurando la configuración ergonómica de monitores, sillas y teclados. 2. Prevención Psicosocial: Incluir pausas activas periódicas de 5-10 minutos cada 2 horas para el descanso físico y mental. 3. Marco Legal: La base regulatoria para la prevención de TME y fatiga visual es el RD 488/1997 sobre trabajo con PVD.

PROBLEMA

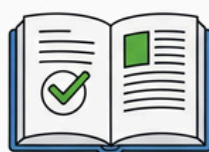
SOLUCIÓN



TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS



Pausa Activa



RD 488/1997





GUÍA RÁPIDA DE BUENAS PRÁCTICAS: ERGONOMÍA ACTIVA Y SALUD MENTAL

ERGONOMÍA Y POSTURA ÓPTIMA

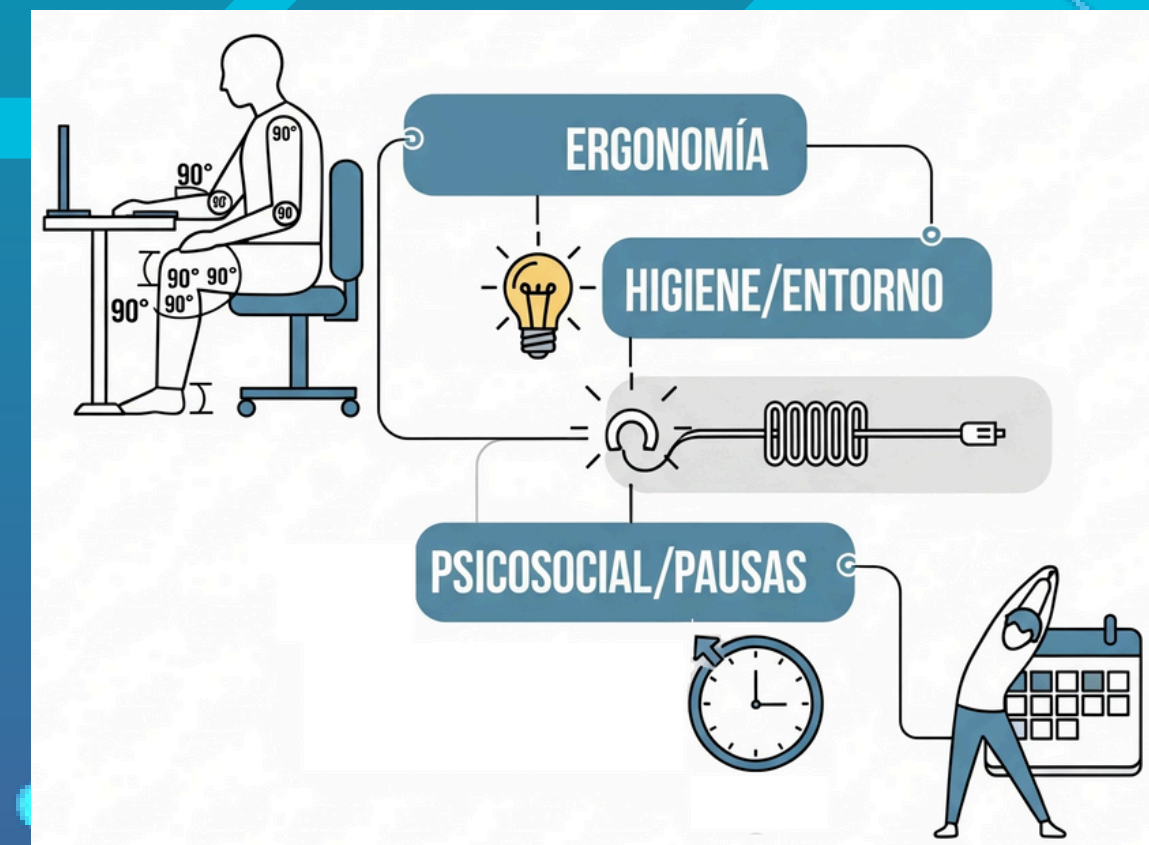
1. Mantener la espalda recta y totalmente apoyada sobre el respaldo, especialmente las lumbares. 2. Los codos deben formar un ángulo de 90° , con antebrazos, muñecas y manos en línea recta. 3. El borde superior del monitor debe estar a la altura de los ojos o ligeramente inferior, y a una distancia de 40-60 cm.

HIGIENE Y ENTORNO DE TRABAJO

1. Usar iluminación uniforme de intensidad adecuada, sin producir brillos, reflejos ni deslumbramientos. 2. Mantener la temperatura ambiente entre 17°C y 27°C (para trabajos sedentarios en oficinas) y la humedad entre el 30% y el 70%. 3. Asegurar el orden y limpieza del puesto, retirando objetos (ej. cables) del suelo para prevenir caídas al mismo nivel.

SALUD PSICOSOCIAL Y PAUSAS

1. Realizar pausas adecuadas (pausas activas) de 5-10 minutos por cada 2 horas para reducir la fatiga mental y física. 2. Fomentar la proactividad, perseverancia y autocontrol como actitudes positivas para el desempeño profesional y la gestión del estrés. 3. Garantizar los descansos y desconexiones durante la jornada, prestando especial atención en el trabajo a distancia (teletrabajo).





GESTIÓN DE LA PRL: MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y AUDITORÍA OBLIGATORIA

MODALIDAD INTERNA (EMPRESA PEQUEÑA)

1. Asunción Personal por el Empresario: Solo posible en empresas de hasta 10 trabajadores (o 25 con un único centro) que no realicen actividades especialmente peligrosas. 2. El empresario debe tener la capacitación de Nivel Básico (30 o 50 horas de formación). 3. Designación de Trabajadores: La empresa puede nombrar uno o varios empleados para realizar las funciones preventivas, dotándoles de tiempo y medios.

MODALIDADES DE SERVICIO (EMPRESA GRANDE)

1. Servicio de Prevención Propio: Obligatorio en empresas con más de 500 trabajadores o entre 250 y 500 si realizan actividades peligrosas (Anexo I). 2. Servicio de Prevención Ajeno: Entidad especializada externa contratada para realizar las actividades preventivas. Es la modalidad más común en el sector terciario/Informático (PYMES). 3. Servicio Mancomunado: Compartido por varias empresas del mismo grupo o sector y ubicación (ej. en un polígono industrial).

AUDITORÍA Y CONTROL EXTERNO

1. La Auditoría es una evaluación externa obligatoria del sistema de prevención, salvo que la empresa tenga un Servicio de Prevención Ajeno. 2. Excepción: Las empresas de hasta 50 trabajadores y actividades no peligrosas están exentas de auditoría externa (solo deben notificar a la Autoridad Laboral). 3. La primera auditoría se realiza a los 12 meses de la planificación preventiva, y se repite cada 4 años (2 años si es actividad peligrosa). vicio de Prevención Ajeno: Entidad especializada externa contratada para realizar las actividades preventivas. Es la modalidad más común en el sector terciario/Informático (PYMES). 3. Servicio Mancomunado: Compartido por varias empresas del mismo grupo o sector y ubicación (ej. en un polígono industrial).





EL CICLO DE PREVENCIÓN: DESDE LA IDENTIFICACIÓN HASTA LA MEJORA CONTINUA

FASE I: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

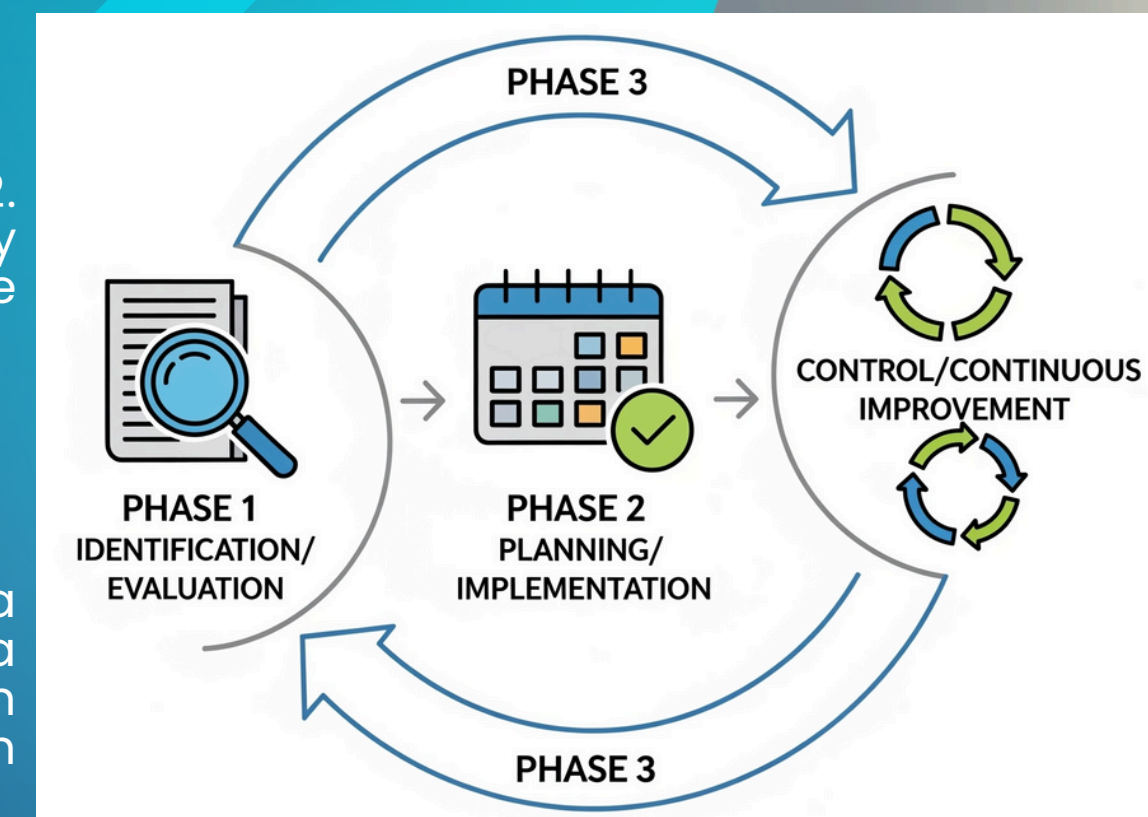
1. El ciclo comienza con la Identificación del Peligro, que es toda fuente potencial de lesiones o daños. 2. Le sigue la Evaluación de Riesgos, que consiste en su Análisis (describir y estimar la probabilidad y gravedad) y su Valoración (determinar si el riesgo es tolerable o intolerable). 3. La evaluación es la base para determinar la necesidad de medidas preventivas.

FASE II: PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

1. Si la evaluación determina un riesgo (moderado, importante o intolerable), se procede a la Planificación de la Actividad Preventiva. 2. La planificación debe ser coherente e indicar las medidas a tomar, el plazo de ejecución, las personas responsables y los recursos. 3. La prioridad de actuación debe estar directamente relacionada con la magnitud del riesgo (ej. riesgo intolerable = acción inmediata).

FASE III: CONTROL Y MEJORA CONTINUA

1. Una vez implementadas, las medidas deben ser objeto de Control y Seguimiento para verificar su eficacia. 2. El ciclo se cierra con la Mejora Continua mediante la revisión periódica del Plan de Prevención y la realización de Auditorías externas. 3. Se debe realizar una nueva evaluación si se producen daños a la salud o se introducen nuevas tecnologías (lo que reinicia el ciclo).



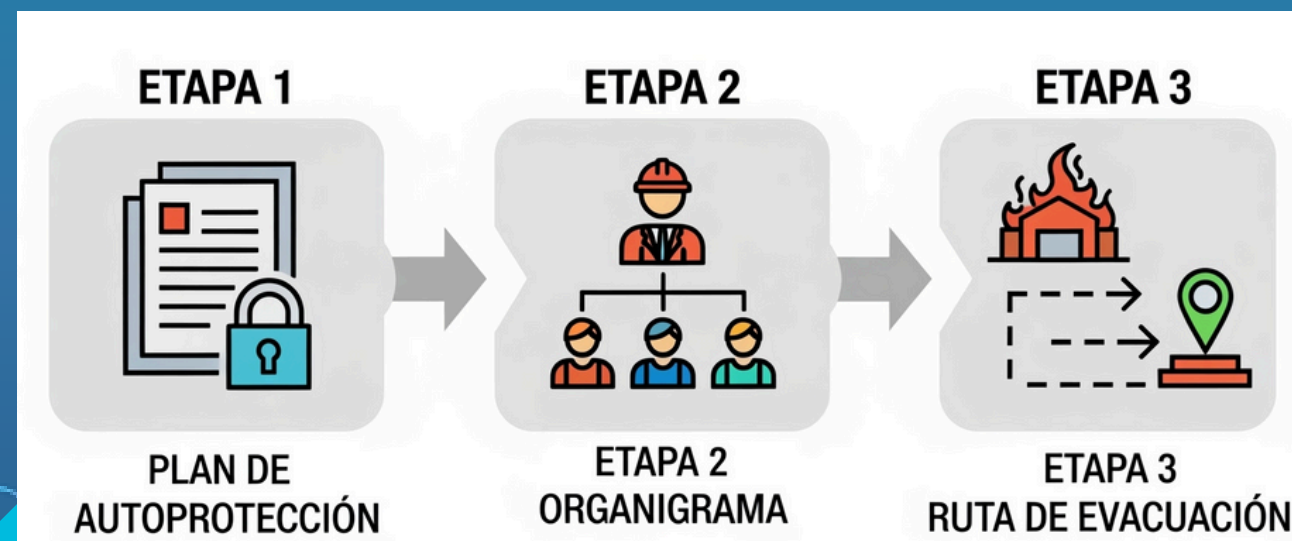


PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: FASES DE ACTUACIÓN Y ROLES DE EMERGENCIA



EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

1. Es el documento que recoge el sistema de control y gestión de la seguridad ante una situación de emergencia (incendio, explosión, inundación, etc.). 2. Incluye el Inventario, Análisis y Evaluación de Riesgos (internos y externos) y los medios materiales/humanos disponibles. 3. El Plan incluye un Plan de Actuación ante Emergencias (qué hacer) y un Plan de Evacuación (cómo salir).



ORGANIZACIÓN Y ROLES DE EMERGENCIA

1. La estructura organizativa es jerarquizada para garantizar una intervención inmediata y coordinada. 2. Director/a del Plan: Activa el plan y dirige/coordina la actuación. 3. Equipos Clave: EPI (Primera Intervención para controlar el conato), EAE (Alarma y Evacuación, dirigen la salida) y EPA (Primeros Auxilios).



FASES DE ACTUACIÓN Y EVACUACIÓN

1. Fase de Alarma: Se detecta la emergencia y se da la alarma (automática o directa), seguida de la confirmación. 2. Fase de Evacuación: Desplazamiento ordenado hasta un espacio exterior seguro (Punto de Reunión), utilizando vías y salidas debidamente señalizadas. 3. Prohibiciones Clave: No utilizar el ascensor, no volver a recoger objetos y no descolgar el teléfono (para mantener las líneas libres).

